

INDICADO POR: Dra Catharina Soares

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

A3124AO2515

MILTON FARIA

IDADE: 45 PESO: 78 ALTURA: 1,56 PROFISSÃO: Padre

SINTOMAS: Sonolência diurna, cansaço ao acordar

QUEIXAS: memória falhando

MEDICAMENTOS: Atilorol / Trazetti / Gaseptogel / Tealozina /

Olifaz / Lorazepam / Azelastin

MÉDICO: Dr. Catharina

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: sedentário

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 19:30h

HORA QUE DORME: 22:30 - 23h HORA QUE ACORDA: 5:30 - 5:45

COCHILO (X) S () N DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S (X) N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 96cm CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: uma alergia MALLAMPATI: III IAH: 509cm SPO2: 81%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: artrose / HAS

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

06/08/25 Análise

marc. Wisp Tudo

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: MILTON FARIA			
Sexo: M	Idade: 74 anos	Peso: 78 Kg	Altura: 1.56 m
IMC: 32.1	Data do Exame: 09/05/2025	Exame: 00553_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:38:14 PM horas e encerrado às 4:04:37 AM horas, com latência para o sono de 3 minutos e latência para o sono REM de 283 minutos. O tempo total de sono foi de 316.0 minutos, com eficiência do sono de 96.6%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.6%	Até 5%
Estágio 2	90.0%	45 - 55%
Estágio 3	3.8%	> 15%
Sono REM	5.5%	20 - 25%
Eficiência do sono	96.6%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 8 minutos ocorreram **212 despertares (índice de 40.3 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 71 bpm, a maior de 86 bpm e a menor de 64 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 268 eventos respiratórios, sendo 0 central e 268 obstrutivos. Sendo 268 apnéias, 0 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 50.9/hora**, sendo 50.9 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 17.9 e a duração máxima de 32.1.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 75.4/hora, sendo 75.4 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **95%**, sendo a saturação média de **91%**, a maior de **97%** e a mínima de **81%**, permanecendo 28.2 minutos (8.6%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 209 dessaturações. Índice de dessaturações: 39.7/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 0.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 42.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Guilherme Salomon de Dominicis
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842